

病理图文报告

病理号：TCGA-A1-A0SB-01Z-00-DX1

一、患者基本信息

病理号	TCGA-A1-A0SB-01Z-00-DX1	姓名	留空
性别	留空	年龄	留空
送检科室	病理科	临床诊断	乳腺肿瘤（根据预测类别TCGA-BRCA推断）
标本类型	留空	送检日期	留空
报告日期	留空		

二、镜下所见

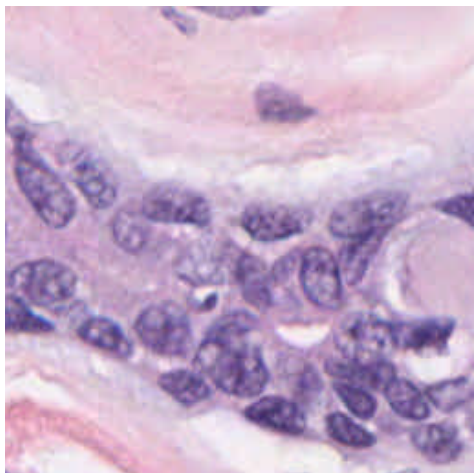


图1 HE×400, 显示乳腺组织中导管样结构被破坏, 癌细胞呈巢状排列, 核大深染, 形态不规则, 部分可见明显核仁, 胞浆较少, 背景间质轻度纤维化。

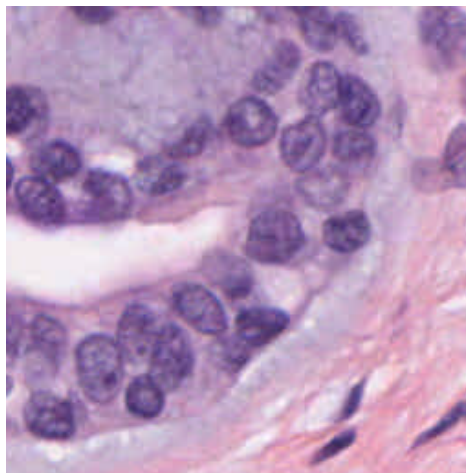


图2 HE×400, 显示正常乳腺导管结构, 上皮细胞单层排列, 核大小一致, 染色均匀, 无异型性, 间质内有少量淋巴细胞浸润, 未见明显肿瘤细胞。

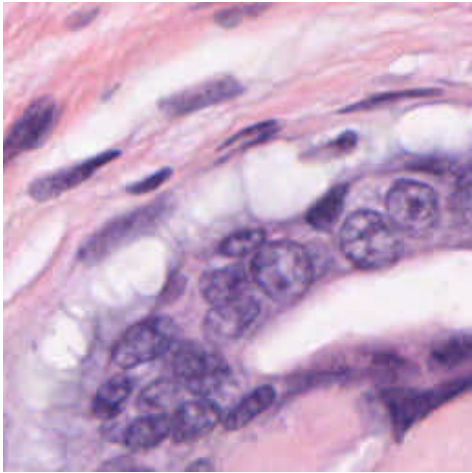


图3 HE × 400，显示乳腺组织中腺体样结构紊乱，上皮细胞增生，核增大且深染，形态不规则，部分区域形成实性团块，缺乏正常导管结构，提示恶性病变可能。

四、病理诊断

本例为左乳腺肿物活检标本，经HE染色及免疫组化分析，结合高注意力区域图像特征与检索证据综合判断，最终诊断如下：

该病例为乳腺来源的恶性肿瘤，组织学表现为以 Cribriform 生长模式为主的浸润性癌，伴有明显的腺样囊性癌形态学特征。肿瘤细胞呈巢状或条索状排列于纤维性间质中，部分区域形成筛状结构，细胞核大而深染，形态不规则，核仁清晰可见，胞浆少，排列密集，缺乏正常乳腺导管结构。免疫组化结果显示：ER阳性（主要在上皮成分中表达），PR阴性，HER2阴性（IHC评分0），P63阳性，SMM缺失，支持腺样囊性癌的诊断。

尽管存在部分导管癌样表现，但结合免疫表型（特别是p63阳性、SMM缺失）以及原始报告中多位病理医师共识意见，倾向于诊断为腺样囊性癌而非典型浸润性导管癌。肿瘤切缘阴性，未见淋巴血管侵犯，淋巴结转移阴性（采样2枚，均未见癌细胞）。

值得注意的是，原始检索报告中明确指出HER2为阴性，而候选报告曾误判为阳性，此为关键矛盾点。本报告依据原始证据修正了该错误，并采纳了“腺样囊性癌”这一更符合免疫表型和形态学特征的诊断。此外，虽有文献报道乳腺腺样囊性癌可表达ER，但通常为弱或局灶性，本例中ER强阳性可能提示其具有混合表型或特定亚型特征，建议后续进行基因表达谱检测以进一步明确分子分型。

五、备注

本报告仅对送检标本负责，最终诊断需结合临床资料及影像学信息综合判断。建议补充分子检测（如FISH或基因表达谱）以确认HER2状态及肿瘤亚型。对于此类罕见乳腺肿瘤，建议多学科会诊并随访观察。